



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : نادية محمود محمود شافعي
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الحوامديه
رقم البطاقة : 24910220102723 رقم التليفون : 01100343492
العنوان : 0
العمر (تاريخ الميلاد) : 22-10-1949 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : ورم بالغدة الدرقية
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : ورم بالغدة الدرقية
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6873] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نادية محمود محمود شافي National ID: 24910220102723	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

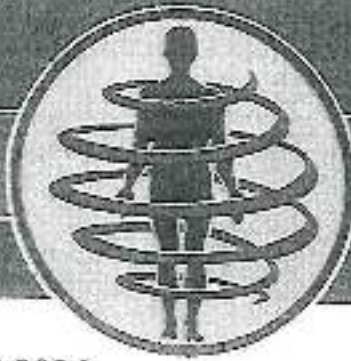
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of thyroid gland tumor for Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Royal Scan

والتحاليل الطبية



رويال سكان

للأشعة التشخيصية

Date: 31 August 2026

Name: Nadia Mahmoud

**CT SCAN EXAMINATION OF THE NECK AFTER I.V.
CONTRAST INJECTION REVEALED:**

- Enlarged left thyroid lobe with heterogenous texture retrosternal extension for FNA.
- Normal size, shape and symmetrical appearance with homogeneous density of right lobe and the isthmus of the thyroid gland. No evidence of nodules, cysts or calcifications is seen.
- No evidence of detectable parathyroid masses or cysts is seen.
- No evidence of lymph node enlargement.
- Normal appearance of the carotid sheath vessels on both sides.
- Normal appearance of the submandibular salivary glands.
- No detectable pharynx or laryngeal abnormality.

KINDLY ACCEPT MY BEST WISHES,

Dr. Ahmad Mokhtar

مخبر الأشعة التشخيصية - تاسمية شارع حسن حلمي على ترعة الخشاب - امام مسجد ابو بكر - هاتف ابراهيم مختار

٢٢٧٥٥٧٢٥



٠١١٥٠٠٠٧٠٠٧



٠١٢٧٤٤٧٥٦٦٦

Patient Name: Nadia Mahmoud

Date of examination: 29 August 2026

ULTRASONOGRAPHIC SCANNING OF THE NECK REVEALED:-

- o Both thyroid lobes: shows homogenous parenchymal texture with scattered nodules.
- o Left lobe irregular hypoechoic nodule measures 16x13mm.
 - The right lobe measures = 17 mm in AP diameter.
 - The left lobe measures = 13 mm in AP diameter.
(enlarged)
 - Isthmus measures = 7 mm(enlarged)
- o Color duplex study revealed normal vascularity.
- o Mild retrosternal extension.
- o Normal appearance of the carotid sheath.
- o Both submandibular and parotid glands are of average size showing homogenous echopattern with no focal lesion.
- o No enlarged deep cervical lymph nodes seen.

CONCLUSION:-

Left lobe suspicious nodule TIRADS IV for histopathological correlation.

Dr.Shaimaa Samir

Name : Nadia Mahmoud Mahmoud Shafai Date : 03-09-2026 08:25
 Branch : Dokki Medical No. : 453347
 Ref.Physician Prof : Sameh Rashwan Ins.Company : Walkin

Whole Body (18F-FDG) PET/CT Study

History and Clinical Data:

Patient data:

- o Weight: 55 Kg, Blood Glucose level: 245 mg/dl.

Clinical background:

- o A 77-year-old female patient with radiologically detected left thyroid lobe nodule, TI-RADS IV

Radiopharmaceutical:

- o 107.3 MBq of 18F-FDG was injected I.V.

Purpose of the study:

- o Assessment of thyroid nodule for any neoplastic tissue

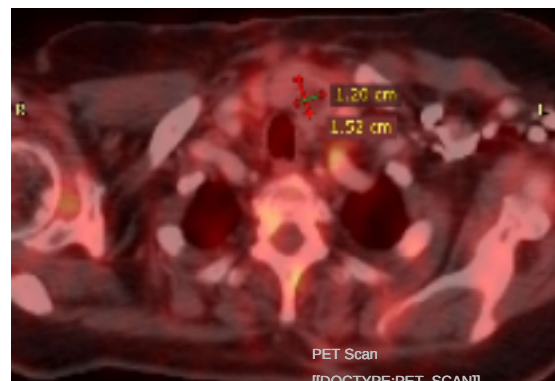
Technique:

- o Imaging was performed on an integrated PET/CT scanner approximately 60 minutes after injection of the radiopharmaceutical.
- o Contrast Enhanced CT images done for attenuation correction and anatomic localization were obtained followed by PET images from the vertex of the skull to the thighs.
- o PET/CT images were reviewed in the transaxial, coronal and sagittal planes.
- o The Standardized Uptake Value, maximum variant (SUV max) was calculated within regions of interest whenever needed.
- o Reference **hepatic SUV max ~ 3.3**

Findings:

I) Head and Neck:

- o No apparent brain focal lesions or pathologic tracer distribution.



Name : Nadia Mahmoud Mahmoud Shafai

Date : 03-09-2026 08:25

Branch : Dokki

Medical No. : 453347

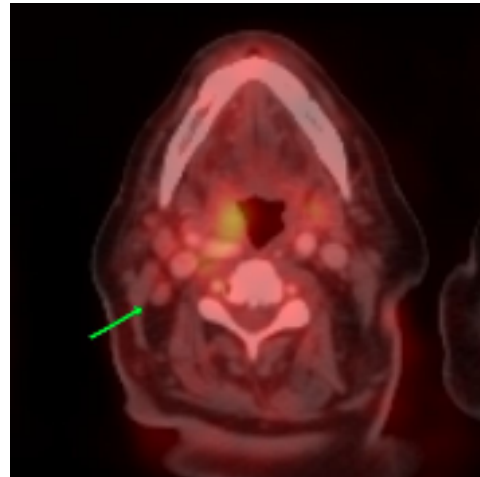
Ref.Physician Prof : Sameh Rashwan

Ins.Company : Walkin

- o Asymmetrical increased FDG uptake at enlarged right palatine tonsil (SUVmax~3.7), for clinical correlation.
- o **Enlarged thyroid gland, harboring isometabolic multiple hypodense nodules, the largest is seen at left lobe with peripheral dots of calcifications, measuring about 1.5x1.2 cm with SUVmax~1.8, for further correlation with sonographic results, TI-RADS categorization and FNAC.**
- o Few sub-cm bilateral deep cervical lymph nodes, measuring up to 0.95x0.6 cm with insignificant FDG-uptake (SUVmax~1.4), for correlation with sonographic results.

II) Chest:

- o Normal appearance of both breasts; No FDG-avid focal lesions or masses.
- o No significant FDG-avid or pathologically enlarged axillary or other mammary-related lymph nodes.
- o No FDG-avid pulmonary nodules, masses or infiltrates. Bilateral lower



Name : Nadia Mahmoud Mahmoud Shafai	Date : 03-09-2026 08:25
Branch : Dokki	Medical No. : 453347
Ref.Physician Prof : Sameh Rashwan	Ins.Company : Walkin

ground glass opacities.non FDG avid segmental left anterior upper pleural calcifications.

- o No pleural or pericardial effusion, thickening or masses.
- o No significant FDG-avid or pathologically enlarged hilar, mediastinal, or peri-clavicular lymph nodes.

III) Pelvi-abdomen:

- o Average-sized liver with no FDG-avid focal lesions. No intra or extra-hepatic biliary radicle dilatation.
- o Normal appearance of the spleen, pancreas, kidneys, suprarenals and pelvic structures.
- o No significant FDG-avid or pathologically enlarged pelvi-abdominal lymph nodes.
- o No pelvi-abdominal ascites or fluid collections.
- o Atherosclerotic calcifications are noted within the large vessels.

IV) Musculo-skeletal:

- o No significant FDG-avid osseous foci, sclerotic or lytic lesions.
- o Mild diffuse increased FDG uptake at the spine, likely reactive bone marrow, for CBC correlation
- o Spondylodegenerative changes are noted over the spine.

V) Normal physiological tracer bio-distribution is seen over the brain, bone marrow, glandular structures, heart, bowel and urinary tract.

Conclusion:

Name : Nadia Mahmoud Mahmoud Shafai

Date : 03-09-2026 08:25

Branch : Dokki

Medical No. : 453347

Ref.Physician Prof : Sameh Rashwan

Ins.Company : Walkin

Whole body (FDG) PET/CT study shows:

- Enlarged thyroid gland with isometabolic multiple hypodense nodules, with insignificant metabolic uptake by Few sub-cm bilateral deep cervical lymph nodes, for further correlation with sonographic results, TI-RADS categorization and FNAC.
- No other metabolically active focal lesions at the rest of the surveyed body.

*As Regards,**Dr. Aalaa Wael, MSc
Nuclear medicine**Dr. Yasser Mohamed
Professor of Nuclear Medicine*

جمهورية مصر العربية
بشارة علي السعيد



نانية
محمود محمود شافعي
٣٧ ش. بغداد - ش. الأمير
الحمدية - الجيزة

٢٤٩١٠٢٢٠١٠٢٧

IX4995839



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٥/٣٠



National ID 
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Patient Name: Nadia Mahmoud

Date of examination: 29 August 2026

ULTRASONOGRAPHIC SCANNING OF THE NECK REVEALED:-

- Both thyroid lobes: shows homogenous parenchymal texture with scattered nodules.

○ Left lobe irregular hypoechoic nodule measures 16x13mm.

- The right lobe measures = 17 mm in AP diameter .

- The left lobe measures = 13 mm in AP diameter.

(enlarged)

- Ismuth measures =7 mm(enlarged)

○ Color duplex study revealed normal vascularity.

○ Mild retrosternal extension.

○ Normal appearance of the carotid sheath.

○ Both submandibular and parotid glands are of average size

showing homogenous echopattern with no focal lesion

○ No enlarged deep cervical lymph nodes seen.

CONCLUSION:-

Left lobe suspicious nodule TIRADS IV for histopathological correlation.

Dr.Shaimaa Samir

Patient Name: Nadia Mahmoud

Date of examination: 29 August 2026

ULTRASONOGRAPHIC SCANNING OF THE NECK REVEALED:-

- Both thyroid lobes: shows homogenous parenchymal texture with scattered nodules.

- Left lobe irregular hypoechoic nodule measures 16x13mm.
- The right lobe measures = 17 mm in AP diameter.
- The left lobe measures = 13 mm in AP diameter.
- (enlarged)
- Ismith measures = 7 mm(enlarged)

- Color duplex study revealed normal vascularity.
- Mild retrosternal extension.
- Normal appearance of the carotid sheath.
- Both submandibular and parotid glands are of average size showing homogenous echopattern with no focal lesion
- No enlarged deep cervical lymph nodes seen.

CONCLUSION:-

Left lobe suspicious nodule TIRADS IV for histopathological correlation.

Dr.Shaimaa Samir

Best regards,
Dr. Amira H. Radwan M.D
Radiology Consultant,
NHC, Cairo University

• Cytology evaluation

Required Data:

• Ti-RADS 4: heterogeneous hypoechoic solid wider than tall showing no calcifications

Radiological picture:

- Procedure and possible complications were explained to the patient
- Usual sterilization of site of biopsy
- Local anesthesia (1cc) was infiltrated at site of sampling
- Six alcohol fixed slides and syringe containing cell block are prepared from aspirate of left suspicion thyroid nodule

ULTRASOUND GUIDED FINE NEEDLE ASPIRATION

10/9/2026 :: تاريخ الفحص
692988 :: كود المريض
12260906108 :: رقم الملف
75 :: السن
:: جهة التحليل

معمل جوارن للتحاليل الباثولوجية والانسجية

Prof. Dr. Samia Mohamed Gabal
M.D and Consultant of Pathology.
Professor of Pathology, Faculty of Medicine,
Cairo University.

أ.د. سامية محمد جبال
مستشارة واستشارية الباثولوجيا
أستاذة الباثولوجيا - كلية الطب جامعة القاهرة

PATHOLOGY REPORT

Name: نادية محمود محمود
Age: 75 Y
Specimen: Left thyroid nodule, FNAC.
Referred by: Prof. Dr. SOHEIB
No: 612/2026
Date: 14/9/2026

GROSS:
Six unstained smears and a syringe contain 3 ml of reddish fluid, 4 smears were prepared.

MICROSCOPIC:
Microscopic examination of the smears revealed groups and small follicles of monotonous follicular cells. Scattered another groups showed larger slightly pleomorphic nuclei are seen. Some cells showed eosinophilic cytoplasm. The background showed RBCs.

DIAGNOSIS:
LEFT THYROID NODULE, SONAR GUIDED FNAC:
FOLLICULAR NEOPLASM WITH ONCOCYTIC CHANGES
(BETHASEDA IV), FOR EXCISION.

Ten slides enclosed.

Prof. Dr. Samia M. Gabal